Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5198947-76.2025.8.21.0001/RS

REQUERENTE: SINARA QUEVEDO CUNHA

REQUERIDO: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Trata-se de ção de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por SINARA QUEVEDO CUNHA em face do IPE-SAÚDE. Alegou possuir diagnóstico de C50 - Neoplasia maligna da mama e que, em razão disso, necessitaria fazer uso do medicamento **PEMBROLIZUMABE 200MG**, porém o pedido foi negado administrativamente. Requereu, em tutela de urgência, a determinação de fornecimento do fármaco pelo réu (evento 1, DOC1).

Deferida a gratuidade da justiça e requisitada nota técnica (evento 6, DOC1), sobreveio com conclusão favorável ao fornecimento do medicamento **PEMBROLIZUMABE** (evento 10, DOC1).

Deferida a tutela de urgência (evento 12, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 24, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido, à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 32, CONT1).

A parte autora apresentou réplica (evento 38, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória, nada requereram.

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 49, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

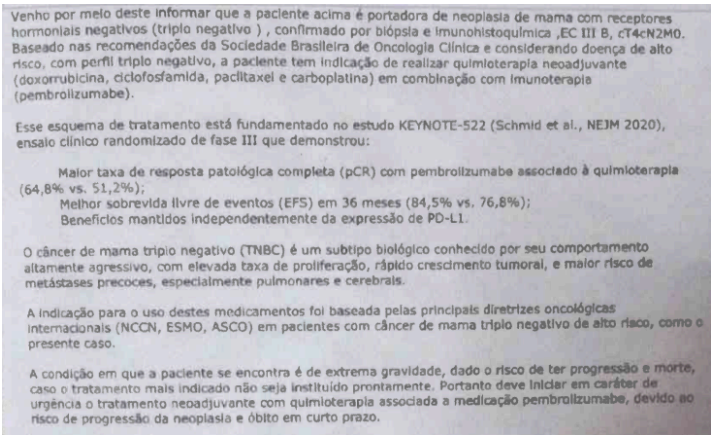
Fundamentação

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

Dito isso, no caso em análise a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 12, DESPADEC1):

> *Segundo o laudo médico acostado aos autos, a parte autora apresenta o diagnóstico de C50 - Neoplasia maligna da mama, necessitando fazer uso do medicamento **PEMBROLIZUMABE .** Ressaltou a **urgência** do tratamento, por se tratar de uma doença agressiva, com risco elevado de progressão rápida e óbito (evento 1, DOC13):*



Venho por meio deste informar que a paciente acima é portadora de neoplasia de mama com receptores hormoniais negativos (triplo negativo) , confirmado por biópsia e imunohistoquímica ,EC III B, cT4cN2M0. Baseado nas recomendações da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e considerando doença de alto risco, com perfil triplo negativo, a paciente tem indicação de realizar quimioterapia neoadjuvante (doxorrubicina, ciclofosfamida, paclitaxel e carboplatina) em combinação com imunoterapia (pembrolizumabe).

Esse esquema de tratamento está fundamentado no estudo KEYNOTE-522 (Schmid et al., NEJM 2020), ensaio clínico randomizado de fase III que demonstrou:

Maior taxa de resposta patológica completa (pCR) com pembrolizumabe associado à quimioterapia (64,8% vs. 51,2%);
Melhor sobrevida livre de eventos (EFS) em 36 meses (84,5% vs. 76,8%);
Benefícios mantidos independentemente da expressão de PD-L1.

O câncer de mama triplo negativo (TNBC) é um subtipo biológico conhecido por seu comportamento altamente agressivo, com elevada taxa de proliferação, rápido crescimento tumoral, e maior risco de metástases precoces, especialmente pulmonares e cerebrais.

A indicação para o uso destes medicamentos foi baseada pelas principais diretrizes oncológicas internacionais (NCCN, ESMO, ASCO) em pacientes com câncer de mama triplo negativo de alto risco, como o presente caso.

A condição em que a paciente se encontra é de extrema gravidade, dado o risco de ter progressão e morte, caso o tratamento mais indicado não seja instituído prontamente. Portanto deve iniciar em caráter de urgência o tratamento neoadjuvante com quimioterapia associada a medicação pembrolizumabe, devido ao risco de progressão da neoplasia e óbito em curto prazo.

*A nota técnica, por sua vez, sobreveio com **conclusão favorável** ao fornecimento do medicamento **PEMBROLIZUMABE**, indicando a urgência do caso (evento 10, DOC1):*

Tecnologia: PEMBROLIZUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO as informações disponibilizadas nos documentos médicos acostados aos autos, em que pesem as peculiaridades do caso em tela;
CONSIDERANDO as limitações inerentes ao tipo de análise meramente documental que caracteriza a atuação dos NATJus;
CONSIDERANDO que o tratamento pleiteado não possui dispensação prevista pela parte ré;
CONSIDERANDO a gravidade da doença que acomete a parte autora;
CONSIDERANDO as evidências científicas existentes;

CONSIDERANDO que o caso do processo em tela não se enquadra nos critérios de urgência ou emergência, conforme as respectivas definições pelo Conselho Federal de Medicina;
CONCLUI-SE que HÁ elementos para subsidiar um parecer favorável, do ponto de vista técnico, para o fornecimento do tratamento pleiteado à parte autora, por via judicial.

*Ademais, foi juntada ao feito a negativa administrativa do **IPÊ**-SAÚDE (evento 1, DOC19).*

*Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do **IPÊ**-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.*

Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Por fim, ressalto que, embora este juízo não desconheça que a Lei Complementar nº 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Dessa forma, comprovados a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 1, DOC13), que indica possuir a parte autora diagnóstico de CID C50 - Neoplasia maligna da mama e, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Pembrolizumabe**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento, uma vez há grande risco de progressão, culminando em óbito.

Com efeito, o médico assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

No mais, a assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Aliás, em 06.04.2018 entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Desse modo, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo médico assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

É falar: não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

A valer, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento almejado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por SINARA QUEVEDO CUNHA em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Pembrolizumabe,** na dosagem e periodicidade determinadas pelo médico assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** à procuradora da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN ALEXANDRE IORIS, Juiz Substituto**, em 16/01/2026, às 14:46:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10098447693v5** e o código CRC **b7b6ac09**.